

Prevención de caídas, transferencias y movilización segura

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Reducir caídas y lesiones al caminar, ejercitarse y pasar entre silla, camilla y otras superficies.

2. Alcance y condiciones de uso

Todos los usuarios con especial atención a movilidad reducida, alteración del equilibrio, sedación ajena, hipotensión, fatiga y ayudas técnicas.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Evaluar historial de caídas, marcha, equilibrio, visión, cognición, calzado, ayudas y sínt

Evaluar historial de caídas, marcha, equilibrio, visión, cognición, calzado, ayudas y síntomas actuales. Elegir instrumento cuando sea apropiado, sin considerar una escala única como exigencia universal.

2. Inspeccionar piso seco, espacio, iluminación, obstáculos, frenos y estabilidad de camilla

Inspeccionar piso seco, espacio, iluminación, obstáculos, frenos y estabilidad de camilla o silla. Ajustar altura y mantener ayuda y llamado al alcance.

3. Explicar transferencia, acordar ritmo y comprobar que el paciente puede colaborar

Explicar transferencia, acordar ritmo y comprobar que el paciente puede colaborar. Solicitar segundo apoyo o dispositivo cuando la carga o condición lo requiere; no levantar solo a alguien que excede capacidad segura.

4. Acompañar marcha o ejercicio con nivel de asistencia documentado

Acompañar marcha o ejercicio con nivel de asistencia documentado. Vigilar mareo, pérdida de equilibrio, dolor y fatiga; detener y sentar o posicionar de forma segura.

5. Si ocurre caída, detener actividades, evaluar daño dentro de competencia y activar emergen

Si ocurre caída, detener actividades, evaluar daño dentro de competencia y activar emergencia si procede. No levantar de inmediato a quien presenta sospecha de lesión importante; informar, registrar y preservar hechos.

6. Analizar barreras fallidas, reparar entorno o equipo y modificar plan

Analizar barreras fallidas, reparar entorno o equipo y modificar plan. Comunicar precauciones al paciente y registrar verificación de eficacia.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Evaluación previa y ante novedades.

Registro del nivel de asistencia.

Indicador: caídas / sesiones del periodo x 1000, con denominador real.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Riesgos individuales	
Estado del entorno	
Ayuda y asistencia	
Transferencia prevista	
Síntomas	
Evento y atención	
Comunicación	
Causa y barrera	
Medida	
Eficacia	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576